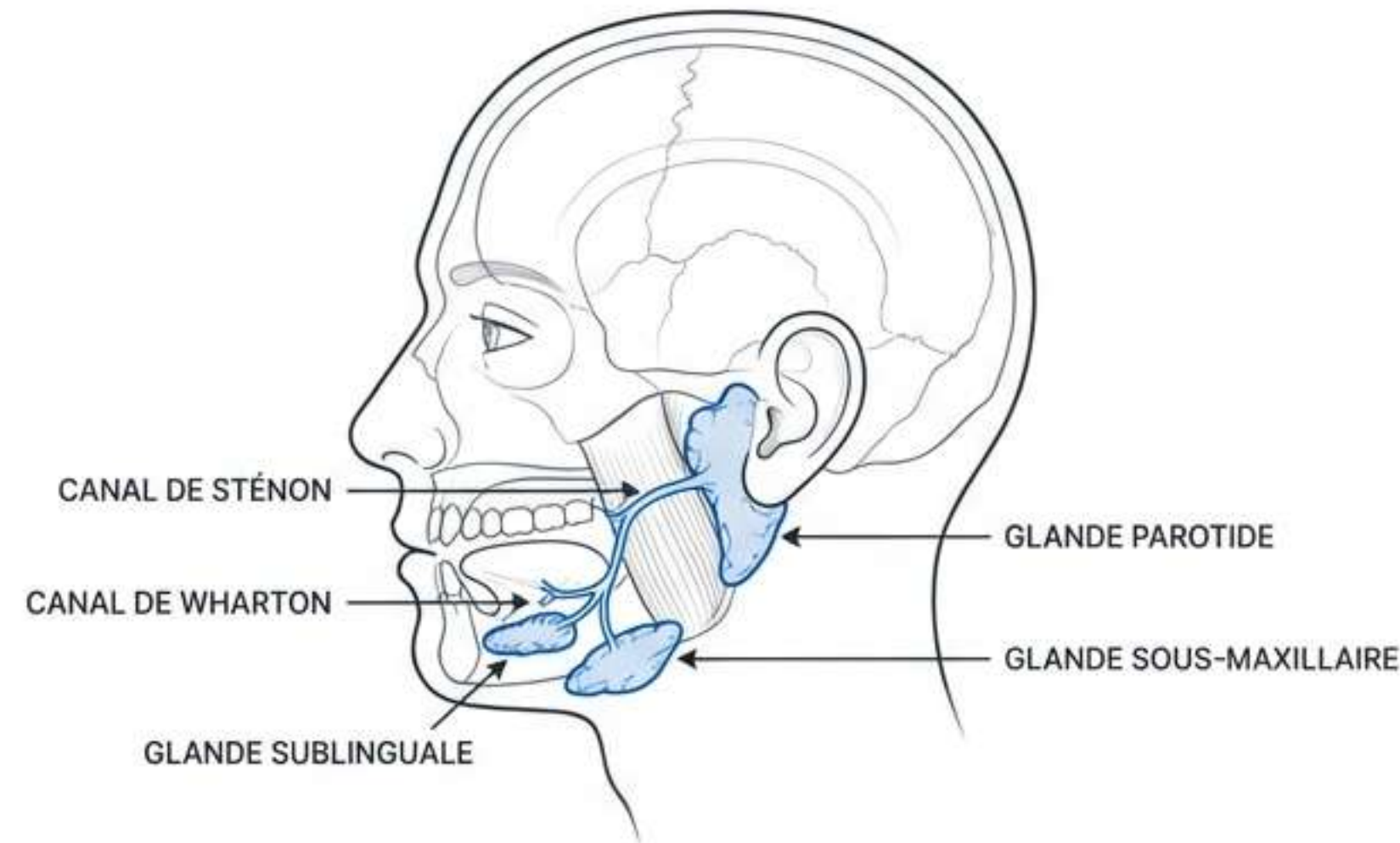
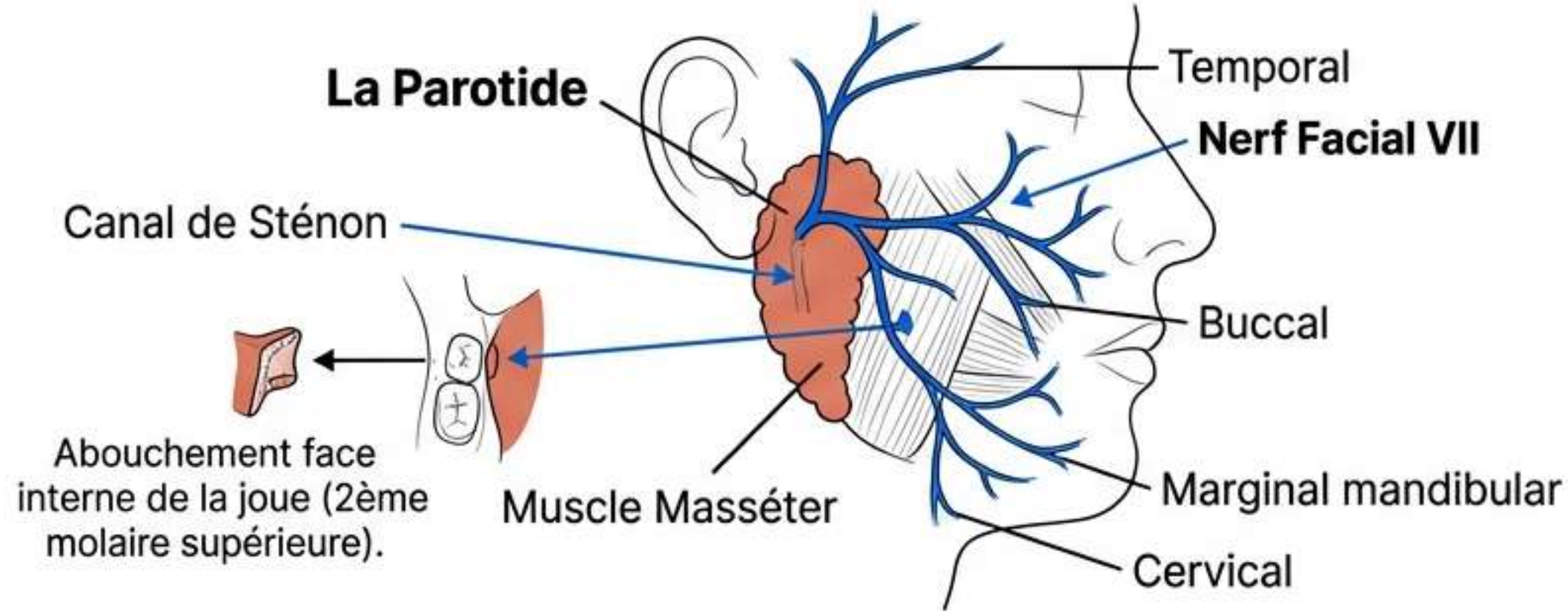


PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES

Polycopié de Cours & Guide de Révision (Examens Q1-Q21)



Rappels Anatomiques : Glandes Principales



1. La Parotide:

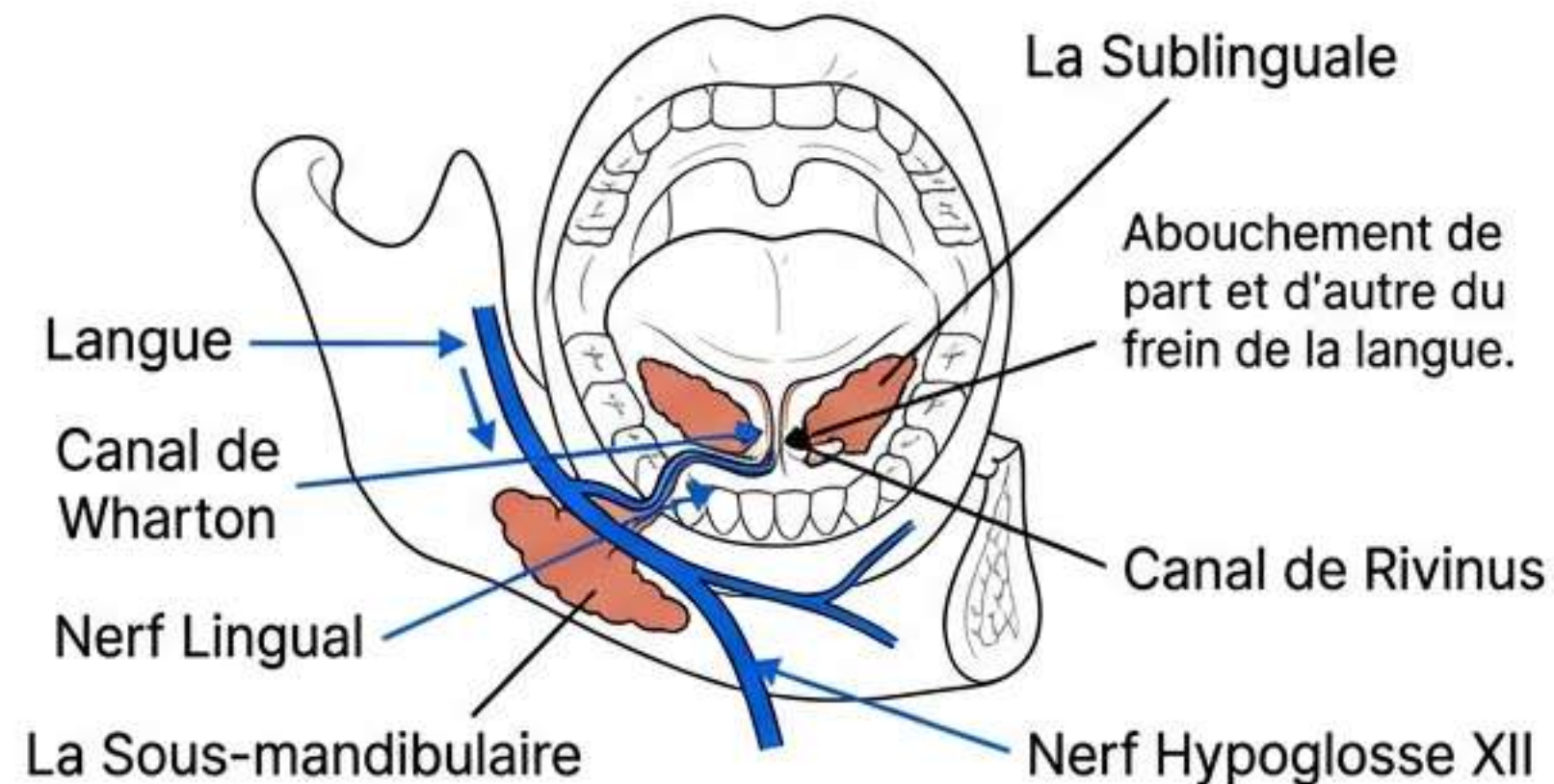
Palpation : En arrière de la branche montante. Tuméfaction refoule le lobule de l'oreille.

Rapport Nerveux : Traversée par le nerf facial (VII) qui sépare la glande en lobes superficiel et profond.

2. La Sous-mandibulaire:

Palpation : Sous le rebord basilaire, doigts en crochet.

Rapports : Longée en dedans par le nerf lingual (sensitif) et le nerf hypoglosse (XII moteur).

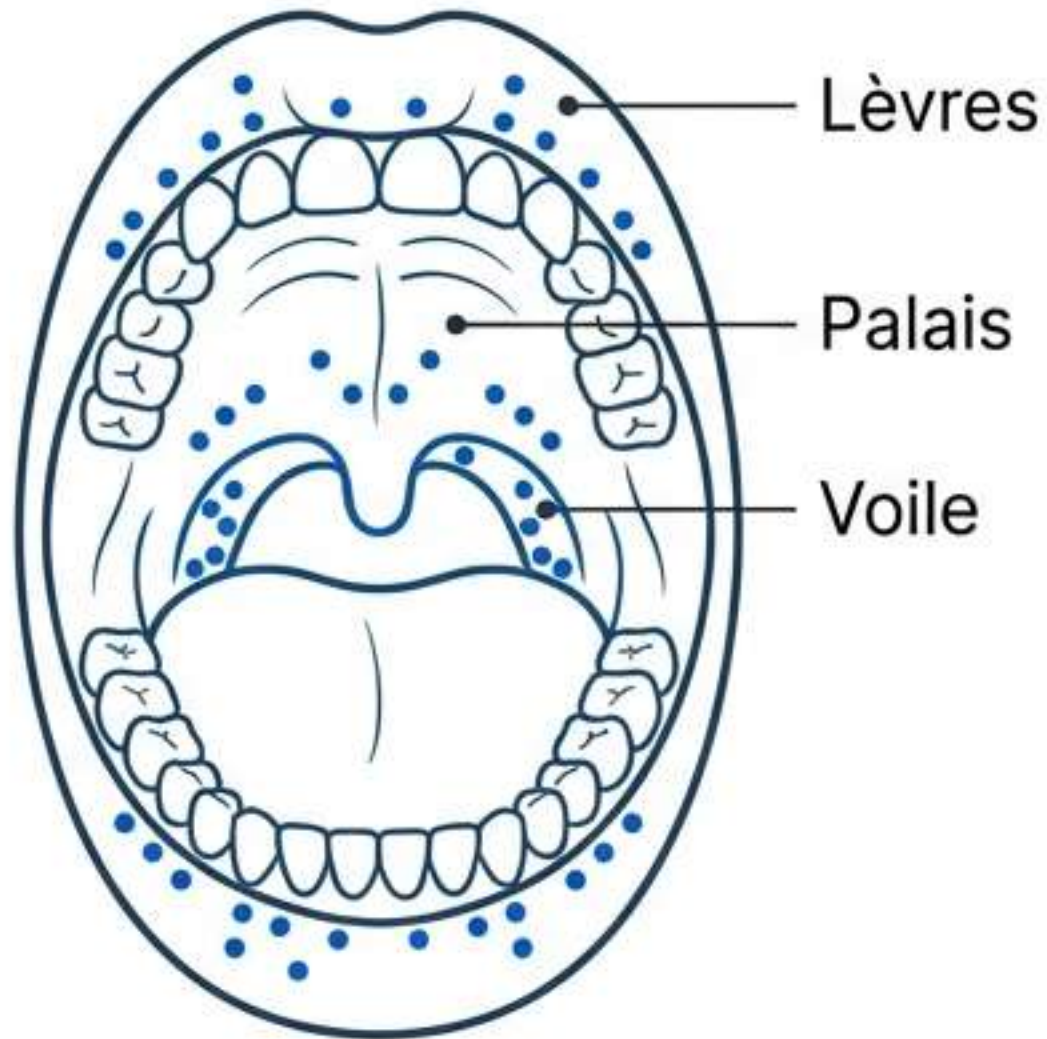


3. La Sublinguale:

Canal de Rivinus : Adjacent à l'ostium du Wharton.

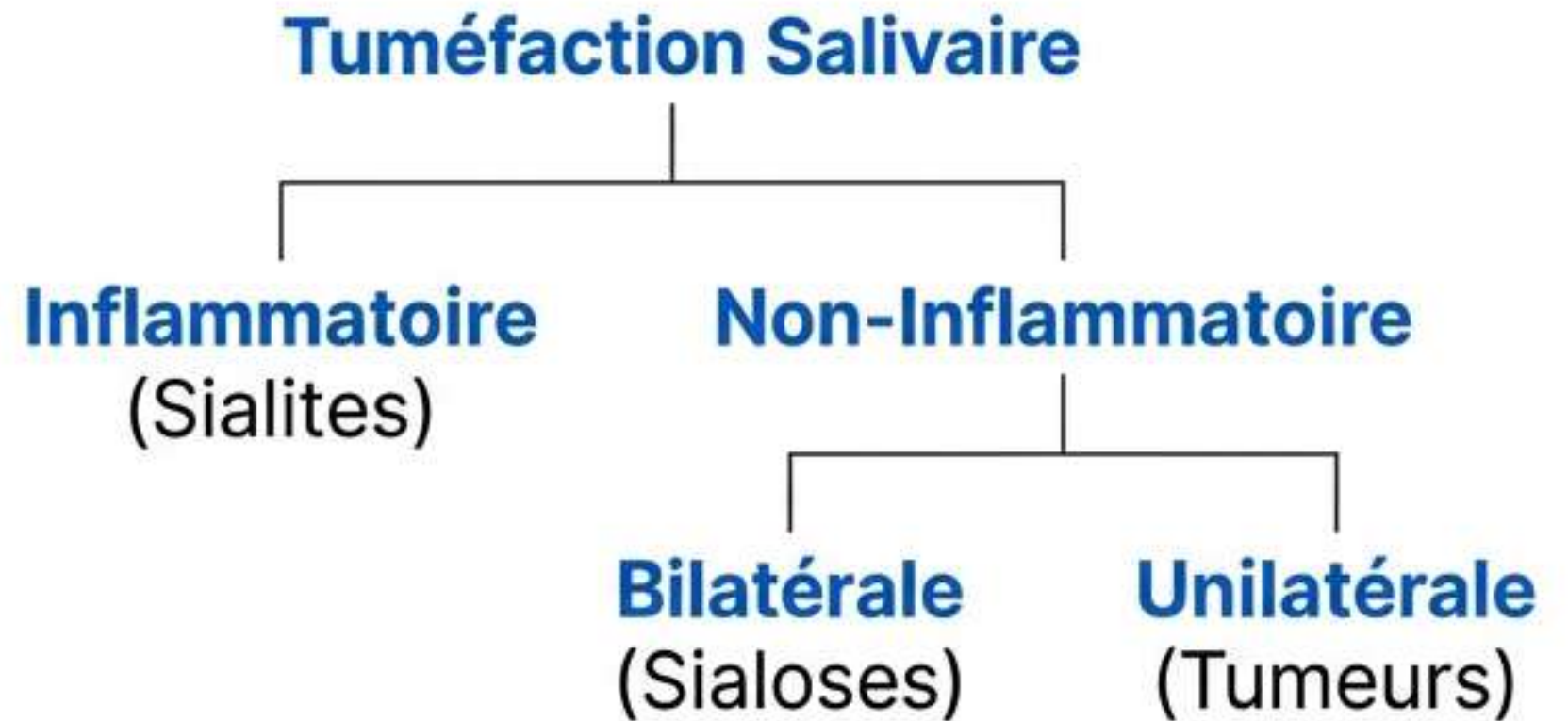
Clinique : Tuméfaction à expression endo-buccale (Ranula/Grenouillette) [Ref: Q16].

Glandes Accessoires & Algorithme Diagnostique



Glandes Accessoires

- Petite taille, réparties dans toute la muqueuse (lèvres, palais, voile).
- Pathologie peu fréquente mais souvent tumorale maligne [Ref: Q13].



Le Diagnostic Causal (La Fourche)

- Inflammatoire : Cause généralement reconnue.
- Non Inflammatoire : Cause découverte souvent à l'examen anatomo-pathologique.

Règle Clinique

Unilatérales = Tumeurs (Chirurgie)

Bilatérales = Sialoses (Pathologie générale)

CAT : Tuméfaction Non Inflammatoire Unilatérale



Bénignité



Malignité

Signes Cliniques

- Isolé, asymptomatique, régulier, mobile.

Signes Cliniques

Adénopathies (ADP), Paralysie Faciale (PF), Trismus, Douleurs, Fixité.

Stratégie d'Imagerie

Absence de signes malins : Echographie + Cytoponction.

Stratégie d'Imagerie

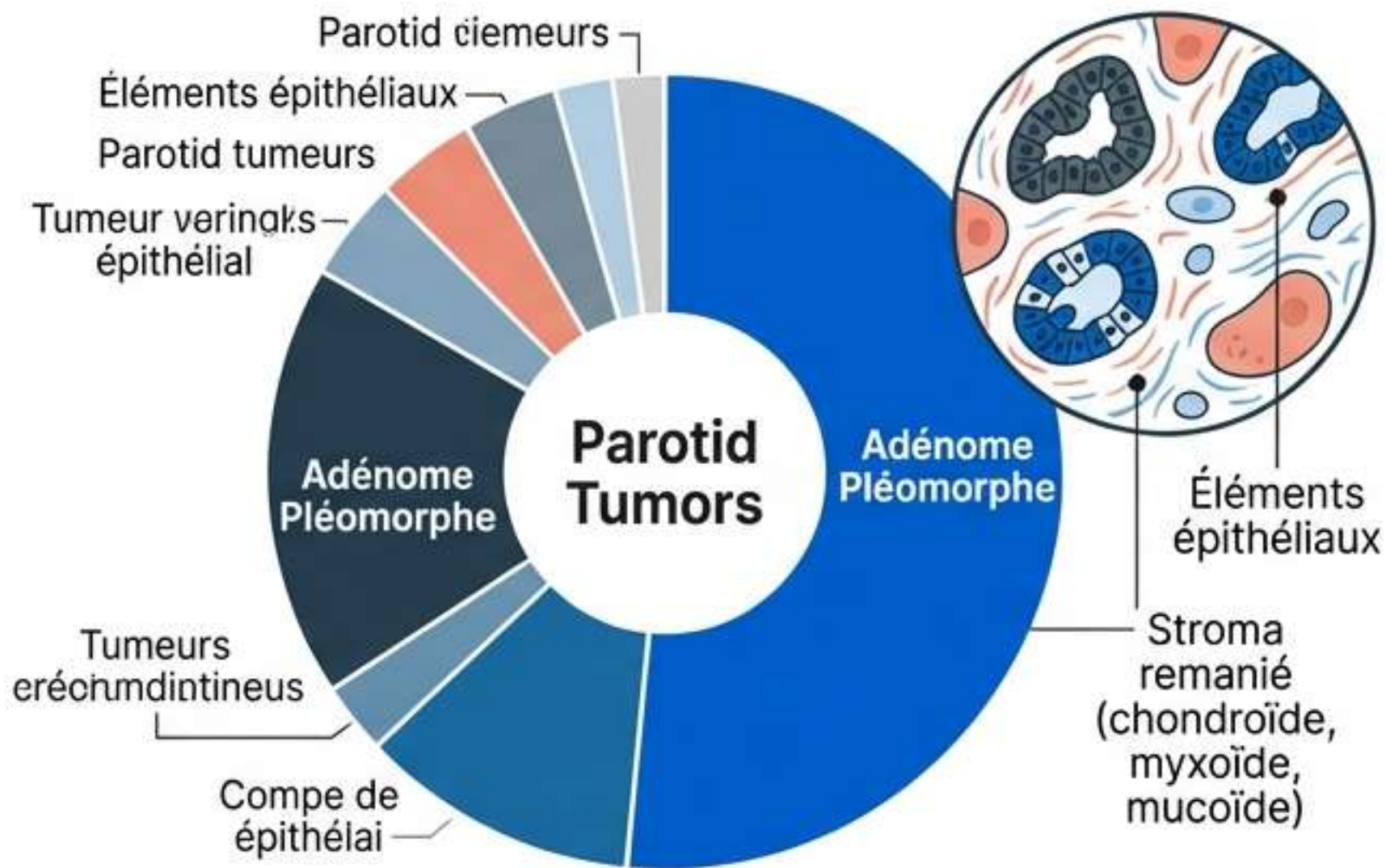
IRM ++ ou TDM injectée (étude de résécabilité).



L'Acte Chirurgical (Règle d'Or)

- Parotidectomie Exploratrice : Exérèse + examen extemporané.
- Interdiction de biopsie simple sur la parotide.
- Si malignité confirmée : +/- Curage cervical.

Tumeurs Bénignes - L'Adénome Pléomorphe (1/2)



Définition

- Appelé aussi 'Tumeur Mixte' [Ref: Q2, Q5, Q14].
- Tumeur bénigne épithéliale [Ref: Q2, Q8, Q12, Q17].

Épidémiologie

- Tumeur la plus fréquente des glandes salivaires (>50% parotide, 80% des bénignes) [Ref: Q8, Q10].
- Siège de prédilection : Glande Parotide [Ref: Q2, Q15, Q18, Q19].
- Age : 30-60 ans.

Histologie

- Caractérisé par la diversité de ses aspects histologiques [Ref: Q1, Q14].
- Coexistence d'éléments épithéliaux et mésenchymateux (stroma remanié chondroïde, myxoïde, mucoïde) [Ref: Q5, Q17, Q19].

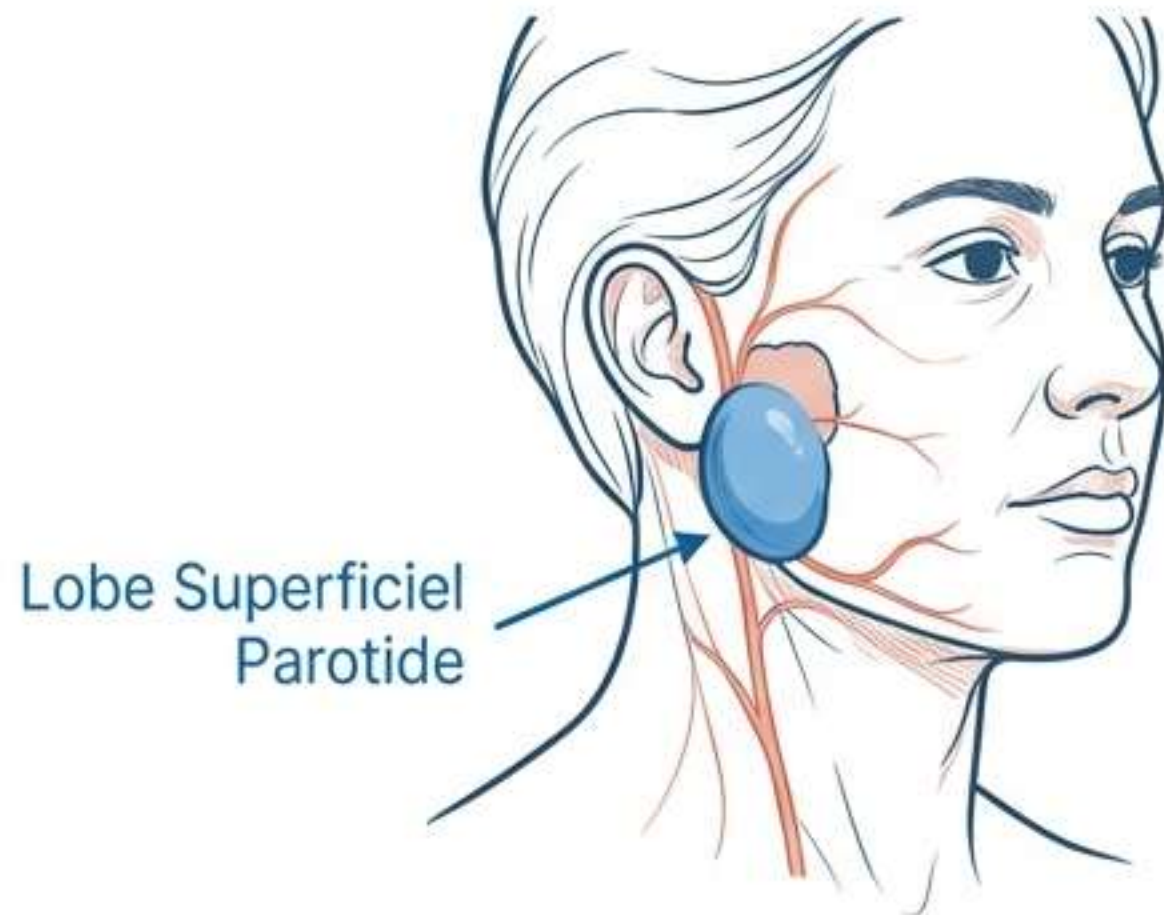
Tumeurs Bénignes - L'Adénome Pléomorphe (2/2)

Clinique

Siège : Lobe superficiel (le plus souvent).

Aspect : Tuméfaction unilatérale, isolée, croissance lente.

Mimique faciale normale (Pas de Paralysie Faciale).



Traitement

Parotidectomie exploratrice avec conservation du nerf facial.

Exérèse sans effraction capsulaire (Dissection minutieuse).

Évolution & Risques

Récidive possible (surtout si exérèse incomplète/effraction capsulaire) [Ref: Q2, Q17, Q18, Q19].

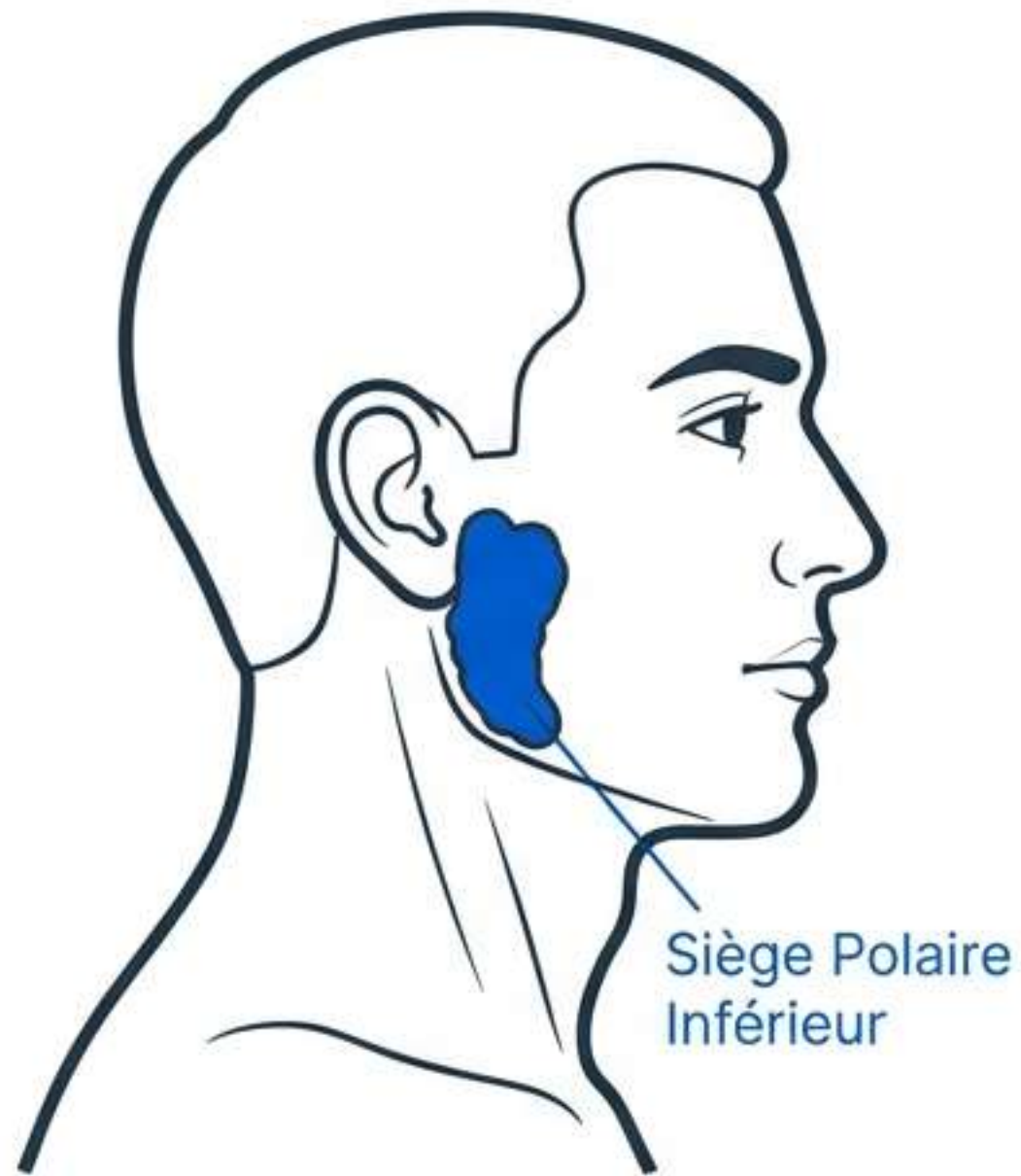
Risque de dégénérescence maligne (Carcinome) : Rare, si évolution longue [Ref: Q17, Q19].



Récidive & Risques

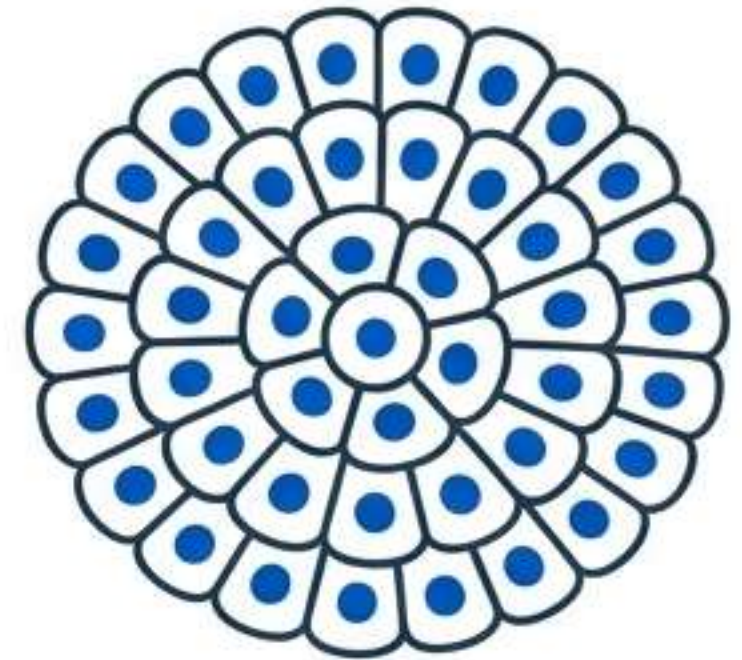
Autres Tumeurs Bénignes

1. Cystadénolymphome (Tumeur de Warthin)



- **Fréquence** : 5 à 10%.
Spécifique de la Parotide [Ref: Q3].
- **Terrain** : Homme de 40 à 60 ans [Ref: Q3].
- **Siège** : Polaire inférieur.
- **Histologie** : Prolifération épithéliale à stroma lymphoïde.
- **Traitement** : Parotidectomie partielle (Bénin).

2. Adénomes Monomorphes



Adénome Monomorphe

- Adénome simple (10-15%).
- Oncocytome (1%, oxyphile).

Tumeurs Malignes (8-18%) : Bas Grade



1. Carcinomes Mucoépidermoïdes (45%)

La plus fréquente des tumeurs malignes.

Histologie : Composante épidermoïde + mucineuse.

Grades : Grade I (Bénin) vs Grade II/III (Haute malignité/Métastases).

Note : Ne pas confondre avec l'Adénome Pléomorphe (Bénin épithélial le plus fréquent) [Ref: Q10].

2. Tumeurs à Cellules Acineuses (10%)

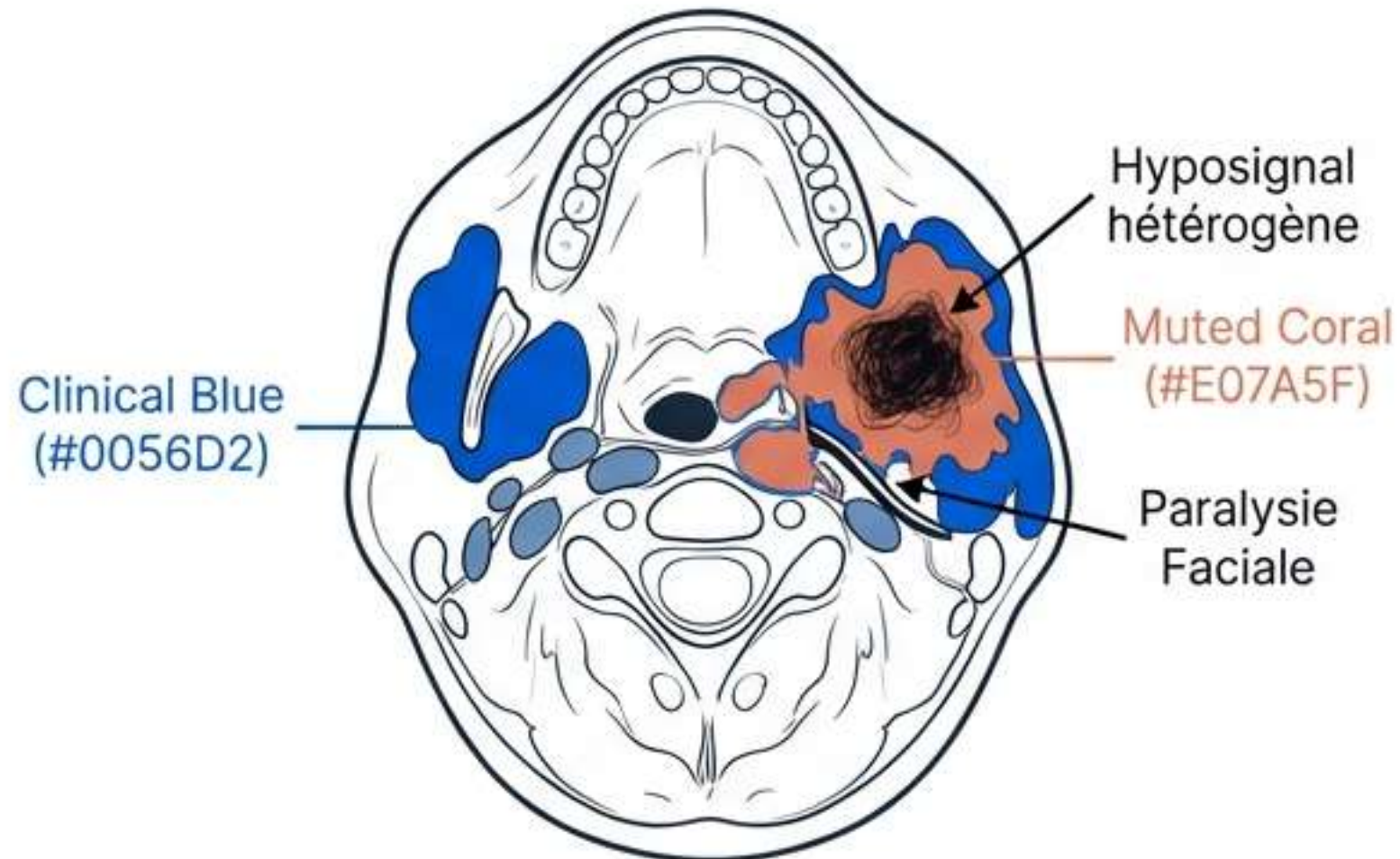
Terrain : Femme (~50 ans).

Évolution : Métastases possibles (5-10%) malgré une survie élevée (80% à 5 ans).

Tumeurs Malignes : Haut Grade (Adénocarcinomes)

1. Généralités (20%)

- Tout âge. Croissance rapide, infiltration diffuse.
- **Signes** : Douleur, ADP cervicales, Paralysie Faciale.



2. Imagerie (IRM)

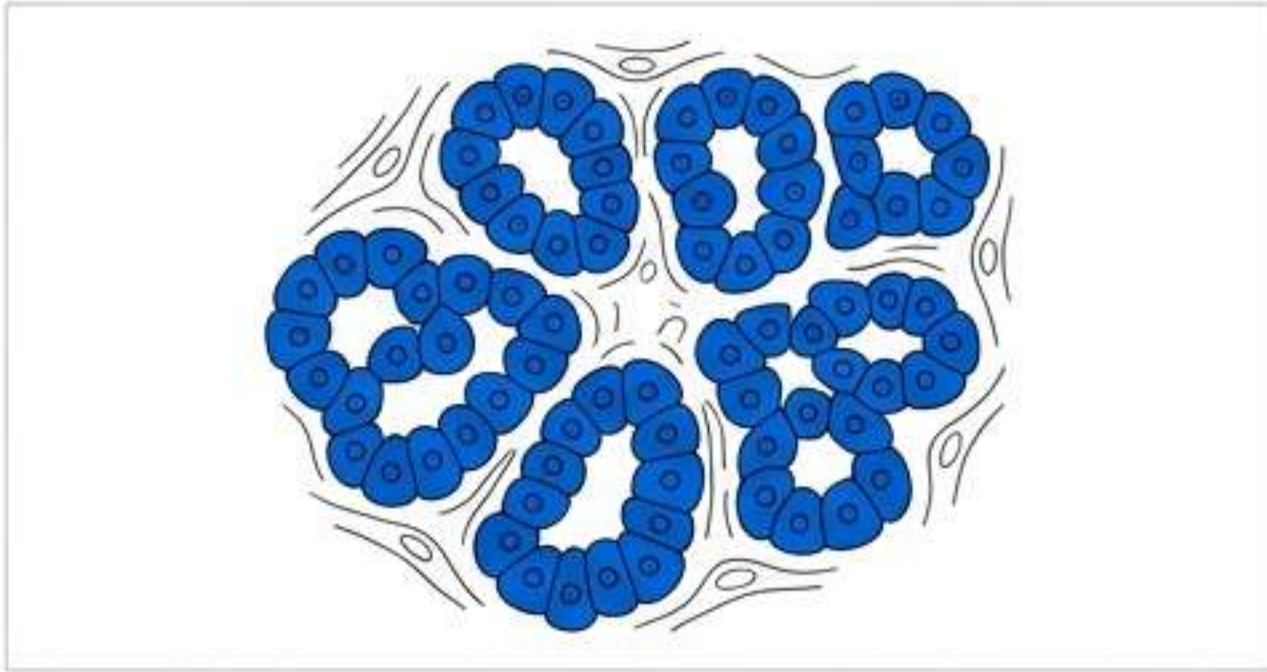
- Contours mal définis.
- Hyposignal hétérogène T1 + Forte prise de contraste.

3. Traitement Agressif

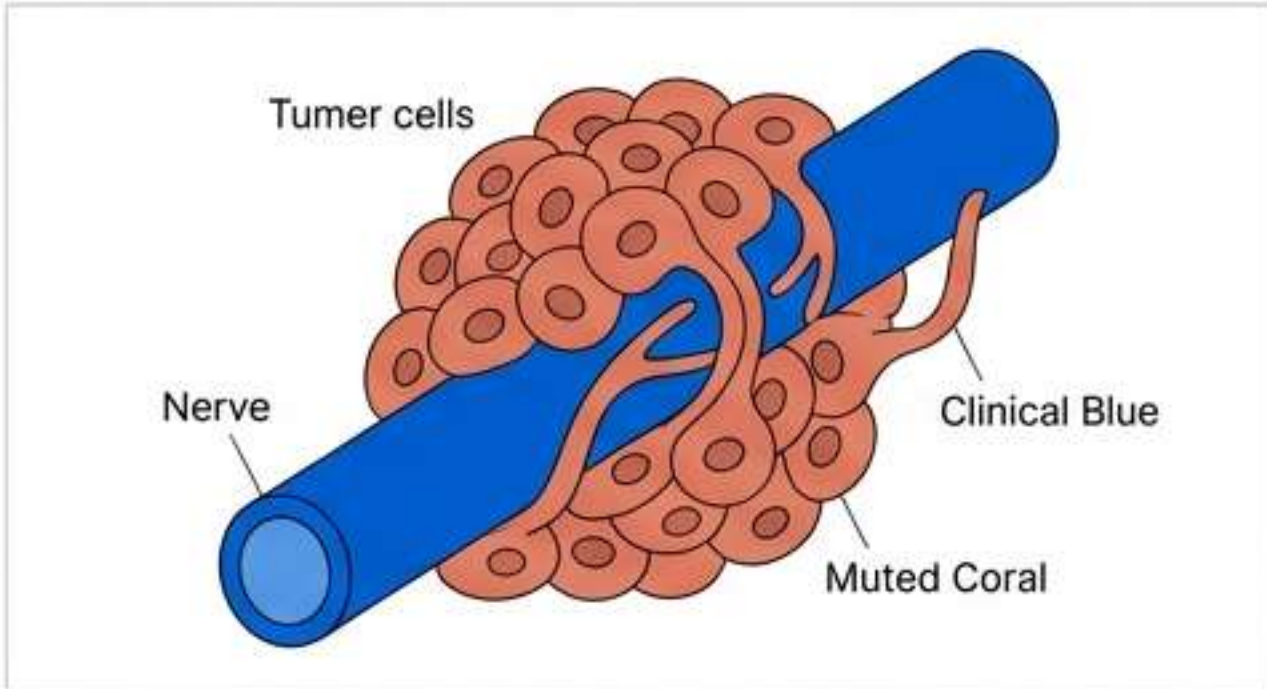
- Parotidectomie totale + Évidement ganglionnaire + Radiothérapie.

Pronostic très péjoratif.

Le Cylindrome (Carcinome Adénoïde Kystique)



Aspect Cribriforme ("Cylindres")



Envahissement Périnerveux (Neurotropisme)

Nature

- Tumeur Maligne (10%) [Ref: Q4, Q21].
- Tumeur la plus fréquente des glandes accessoires [Ref: Q13, Q4].

Histologie

- Architecture cribriforme (aspect de 'cylindres') [Ref: Q20].

Caractéristiques Clés (Neurotropisme)

- Envahissement périnerveux marqué (Extension endonerveuse) [Ref: Q4, Q6, Q11, Q20, Q21].

Clinique : Douleurs spontanées, Paralysie Faciale.

Évolution

- Croissance assez lente mais récurrences locales fréquentes [Ref: Q20, Q21].
- Métastases à distance (Poumon, Os) souvent tardives [Ref: Q6, Q21].

Autres Tumeurs Malignes & Synthèse



DANGER

Tumeurs agressives
ant : carcinomes
Carcinomes.
Carcinomes
Épidermoïdes.
Tumeurs.
Carcinomes
tumeurs.

Autres Formes (5%)

- Carcinomes Mucoépidermoïdes Grade III (**Forte malignité**). JetBrains Mono
- Carcinomes Épidermoïdes. JetBrains Mono
- Carcinomes Indifférenciés. JetBrains Mono

Pronostic & Traitement

Pronostic : Très mauvais.

Protocole : Chirurgie radicale (Totale + Curage) + Radiothérapie post-opératoire.

Pathologie Inflammatoire (Sialites)



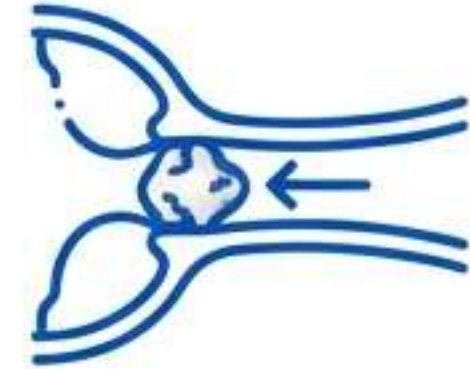
1. Parotidite Ourlienne (Oreillons)

- Bilatérale.
- Cause virale.



2. Parotidite Microbienne

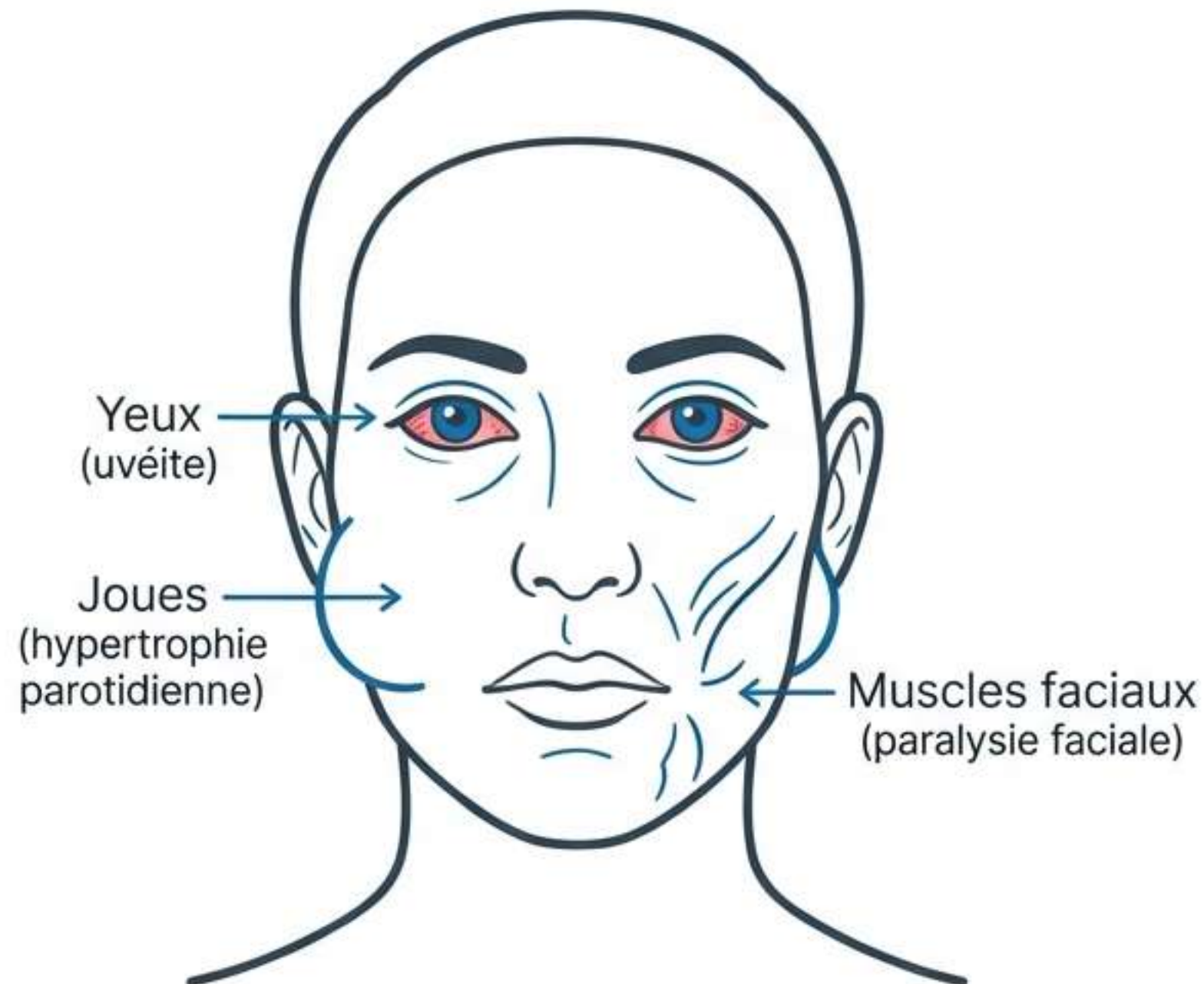
- Unilatérale.
- Aigüe ou Chronique.



3. Lithiase Salivaire

- Concerne les glandes principales.
- Touche le plus fréquemment la glande Sous-mandibulaire [Ref: Q9].
- (Due à la viscosité de la salive et au trajet du canal de Wharton).

Sialoses - La Sarcôïdose (Maladie de BBS)



Clinique

- Hypertrophie parotidienne bilatérale, indolore.

Syndrome de Heerfordt

- **Triade** : Uvéoparotidite (Parotidite + Uvéïte) + Paralysie Faciale + Fièvre.

Diagnostic

- IDR négative (Anergie tuberculinique).
- Élévation de l'enzyme de conversion.
- Histologie.

Évolution

- Souvent favorable.

Sialoses - Syndrome de Gougerot-Sjögren

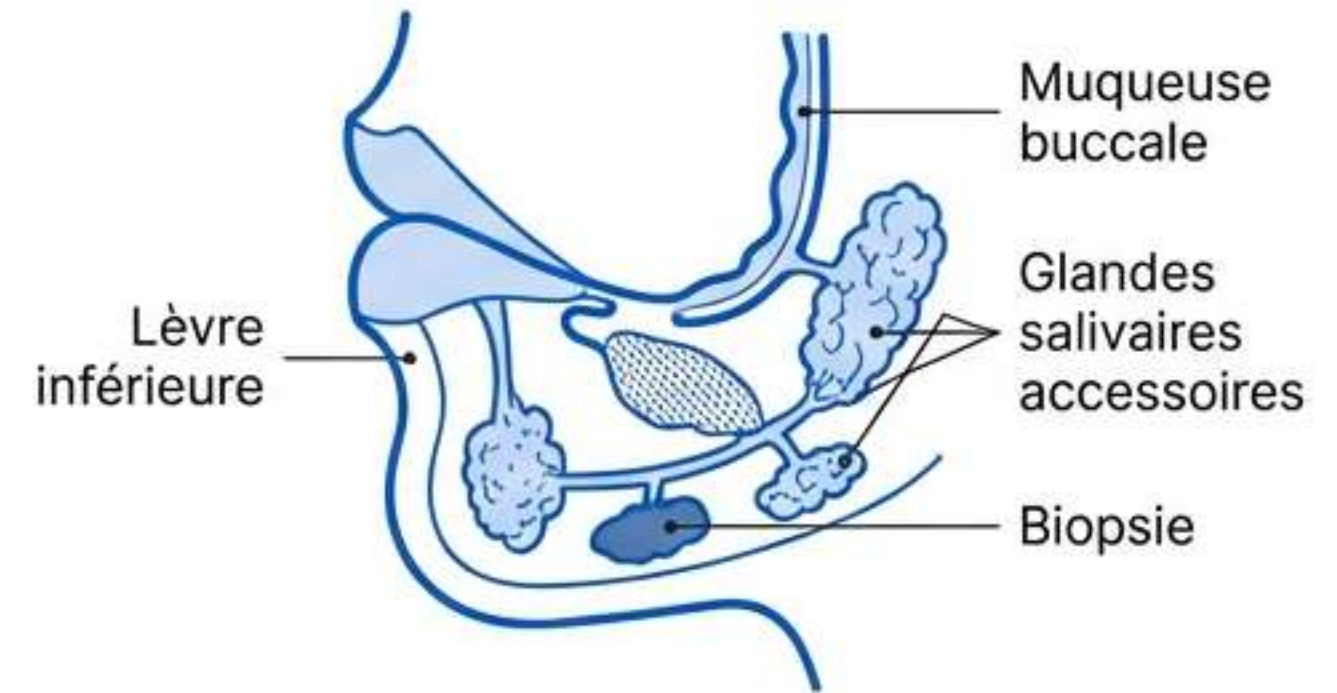


Définition

- Maladie auto-immune (Femme 40-60 ans).
- Isolé ou associé (Polyarthrite Rhumatoïde, LED).

La Triade Clinique

- 1. Gonflement parotidien bilatéral [Ref: Q7].
- 2. Xérophtalmie (Sécheresse oculaire) [Ref: Q7].
- 3. Xérostomie (Sécheresse buccale) [Ref: Q7].



Diagnostic

- Biopsie des glandes accessoires (Lèvre inférieure) : Prélèvement de 3 glandes minimum.

Risque Majeur

- Évolution vers un Lymphome (si tuméfaction nodulaire apparaît) [Ref: Q7].

SYNTHÈSE GLOBALE

